

Botox vésical (pour la vessie hyperactive)

WARWIKI

Information pour le patient · Injections pour calmer une vessie hyperactive

Le Botox vésical est un traitement de la **vessie hyperactive** — urgenturies, mictions fréquentes et fuites — qui n'a pas suffisamment répondu aux modifications de mode de vie ni aux médicaments. De très faibles doses de toxine botulique (Botox) sont injectées dans le muscle vésical à l'aide d'un fin endoscope pour le détendre. L'effet s'installe en 1–2 semaines et dure environ 6 mois.

Comment ça fonctionne

Dans la vessie hyperactive, le muscle vésical se contracte sans raison. Le Botox **détend ce muscle**, ce qui supprime les contractions incontrôlées et réduit les urgenturies, la pollakiurie et les fuites. L'amélioration n'est pas immédiate : elle s'installe progressivement en **1–2 semaines**.

Est-ce sans danger ?

Oui, c'est un traitement bien établi. Le point le plus important : en relaxant la vessie, le Botox peut parfois rendre la vidange vésicale **incomplète** — un petit nombre de patients doivent pratiquer un **auto-sondage temporaire** jusqu'à la disparition de l'effet. Vous devez donc être en mesure d'apprendre cette technique si nécessaire. Les autres effets possibles sont les infections urinaires et un léger saignement passager.

COMPRENDRE LES TERMES

Vessie hyperactive

Urgenturies et mictions fréquentes causées par une contraction prématurée de la vessie.

Toxine botulique (Botox)

Médicament qui détend un muscle par injection.

Détrusor

Muscle vésical dans lequel les injections sont effectuées.

Cystoscope

Fine caméra utilisée pour réaliser les injections.

Auto-sondage

Passage d'une fine sonde pour vider la vessie, parfois nécessaire temporairement.

Résidu post-mictionnel

Urine restant après la miction — vérifié après la procédure.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? Un liquide anesthésiant est instillé dans la vessie au préalable ; la plupart des patients ne ressentent qu'une légère pression pendant les injections. Il s'agit généralement d'une **procédure en cabinet sous anesthésie locale**, d'une durée de 10–15 minutes, et vous rentrez chez vous juste après.

Comment vous préparer

- Une **analyse d'urine** préalable pour écarter toute infection.
- Un **antibiotique** peut vous être prescrit avant ou après la procédure.
- Signalez à votre équipe tout **anticoagulant** et soyez prêt(e) à apprendre l'auto-sondage si besoin.

Déroulement

- 1 Un liquide anesthésiant est instillé dans la vessie.
- 2 Un fin **cystoscope** est introduit par l'urètre.
- 3 Le Botox est injecté en plusieurs points de la paroi vésicale.
- 4 Le cystoscope est retiré — l'ensemble dure environ 10–15 minutes.

Après

- Une légère brûlure ou un peu de sang dans les urines pendant un ou deux jours est normal.
- L'amélioration s'installe en 1–2 semaines ; elle dure environ 6 mois et les injections peuvent être **répétées**.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Impossibilité d'**uriner** ou impression de ne pas vider complètement la vessie
- Fièvre ou frissons (infection possible)
- Saignement abondant ou caillots dans les urines
- Brûlures qui s'aggravent après quelques jours

Bon à savoir

- La vidange vésicale est généralement **vérifiée** après la procédure.
- En cas de renouvellement des injections, elles sont espacées de plusieurs mois.

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Le Botox vésical détend le muscle d'une vessie hyperactive, réduisant urgenturies, pollakiurie et fuites ; l'effet s'installe en 1–2 semaines et dure environ 6 mois.
2. C'est une procédure rapide en cabinet sous anesthésie locale ; la principale contrepartie est que certains patients ont besoin d'un auto-sondage temporaire.
3. Appelez immédiatement si vous ne pouvez pas uriner ou si vous avez de la fièvre après la procédure.